



Emergenze Mediche e Cardiovascolari

Protocolli di Riconoscimento e Gestione Extra-Ospedaliera (Modulo SSE)



Il Ruolo del Soccorritore: Occhi, Orecchie, Metodo



Scena



Valutazione



Comunicazione



SOREU



Valutazione: Approccio ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).



Comunicazione: Trasmissione dati oggettivi alla SOREU.



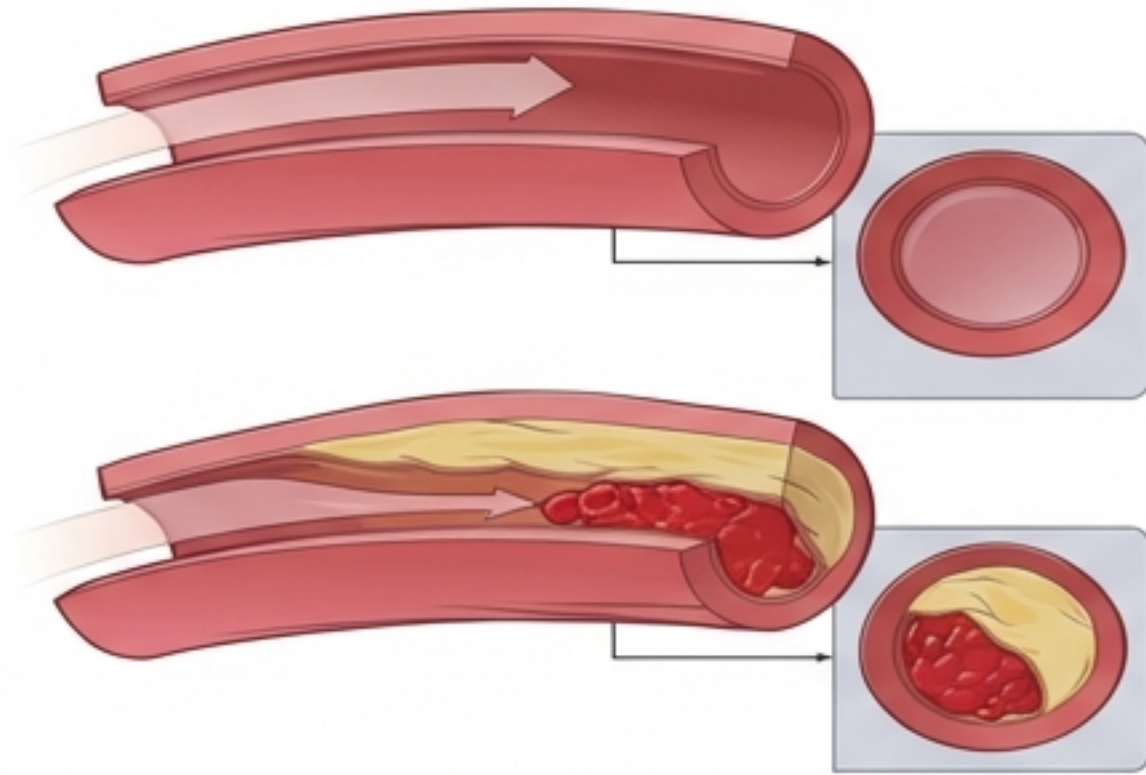
Limite Operativo: Non interpretare, riferire.



**Noi non facciamo diagnosi.
Raccogliamo segni e sintomi per attivare il percorso giusto.**

Ictus Cerebrale (Stroke): Il Tempo è Cervello

TIPOLOGIE DI ICTUS

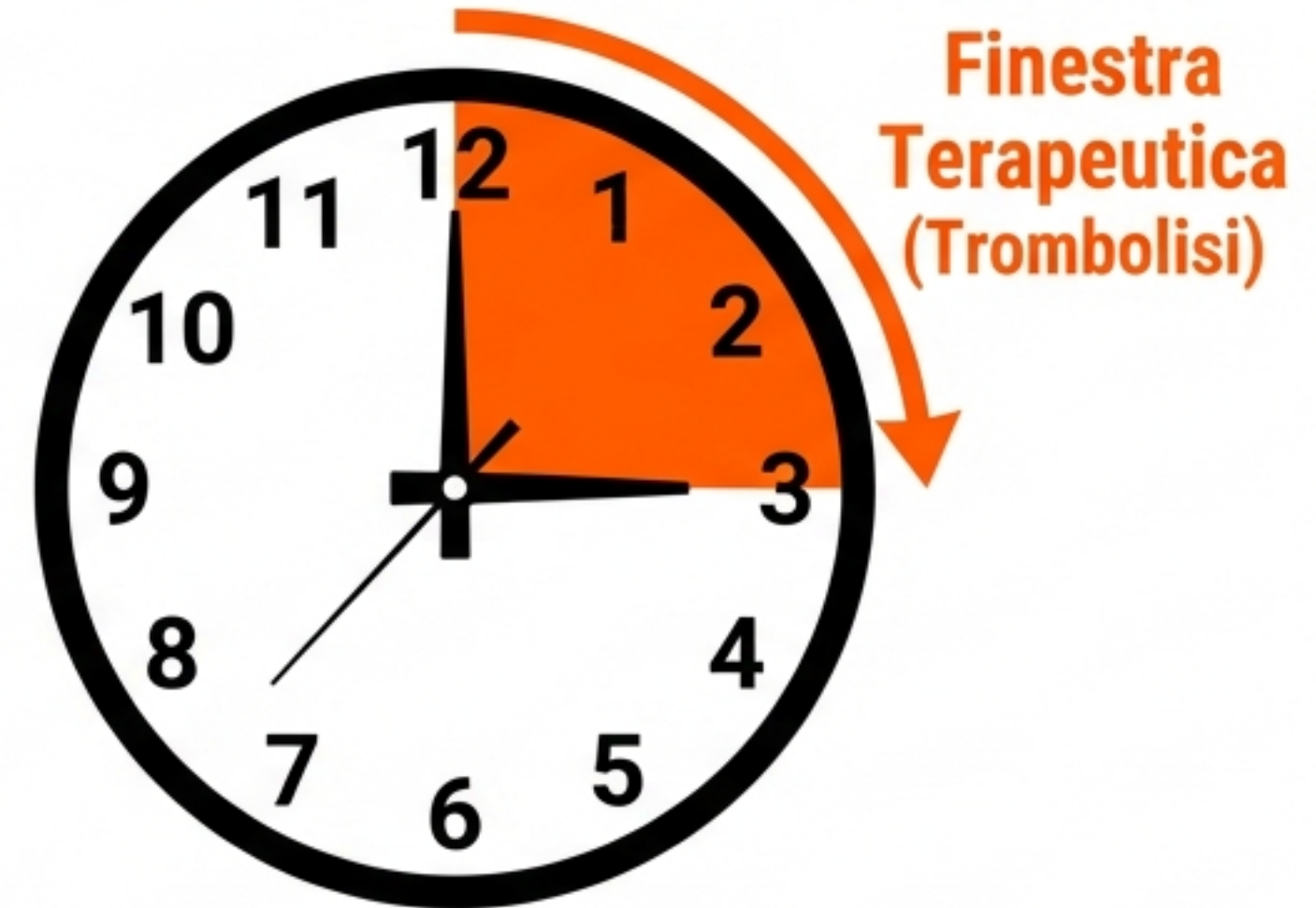


Ictus Ischemico (80%) - Ostruzione



Ictus Emorragico (20%) - Rottura

TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO



Azione Critica: Determinare l'ora esatta di insorgenza.

"L'ultimo momento in cui il paziente stava bene."

Valutazione Rapida: Scala CPSS (Cincinnati)



1. Mimica Facciale:
"Sorridi"

2. Braccia:
"Chiudi gli occhi e
alza le braccia"

3. Linguaggio:
"Come va?"



1 Segno Positivo = Sospetto Ictus → Codice Prioritario

La CPSS è positiva anche con un solo sintomo presente.

Sindrome Coronarica Acuta (IMA)

Tipico:
**Oppressivo,
costrittivo**

- ✓ **Riposo assoluto**
- ✓ **Tranquillizzare**
- ✓ **Monitoraggio parametri**



Nel dubbio, pensare sempre al peggio. Un dolore allo stomaco potrebbe essere un infarto.

**Atipico (Camaleonte):
Dolore epigastrico**

Il Protocollo ECG: Limiti e Responsabilità



ECG Fatto = Ospedale

- ⊗ Non interpretare il tracciato autonomamente
- ⊗ Non fidarsi della lettura automatica della macchina
- ⊗ Non lasciare il paziente a domicilio se l'ECG sembra "normale"

L'ECG è solo uno dei tanti esami necessari. Non è una patente di sanità.

Aritmie e Shock: Quando il Sistema Collassa

Aritmie



Tachicardia >120 bpm

Palpitazioni, "Cuore in gola"



Bradycardia <50 bpm

Rischio Sincope

Shock

Squilibrio tra domanda
e offerta di ossigeno



Pallore



Sudorazione Fredda



Confusione

Se presenti segni di shock → Chiamata Prioritaria

Emergenze Metaboliche: Diabete

↓	Ipoglicemia (<70 mg/dl)	↑	Iperglicemia (>120 mg/dl)
	Agitazione		Sete intensa
	Sudorazione		Poliuria
	Fame d'aria		Alito acetoneo
	Insorgenza Rapida		Insorgenza Lenta



NON somministrare zucchero o insulina senza autorizzazione della SOREU.

La risalita glicemica potrebbe non essere stabile. Trasporto quasi sempre necessario.

Reazioni Allergiche e Anafilassi

Triggers



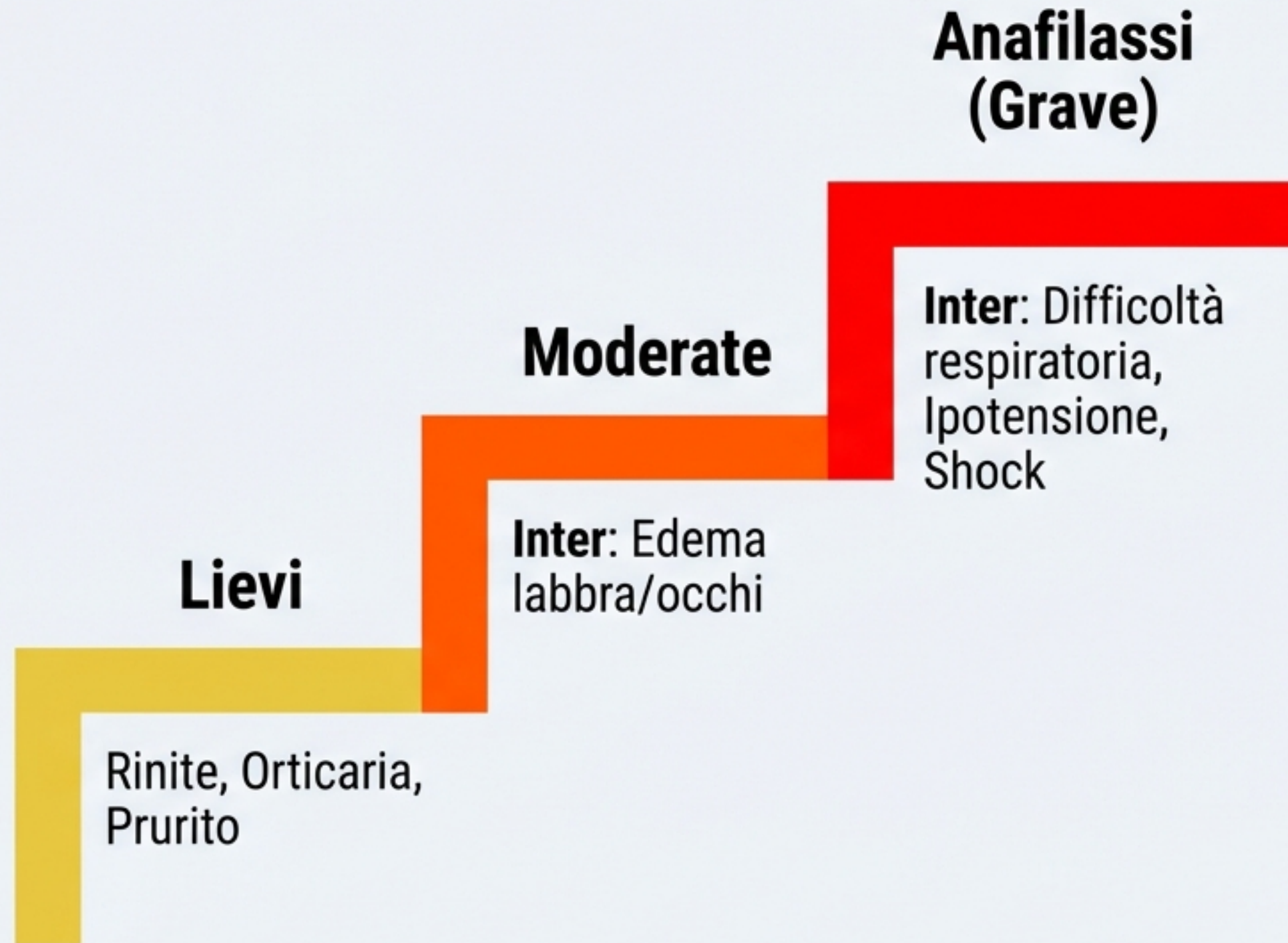
Food



Pills



Insects

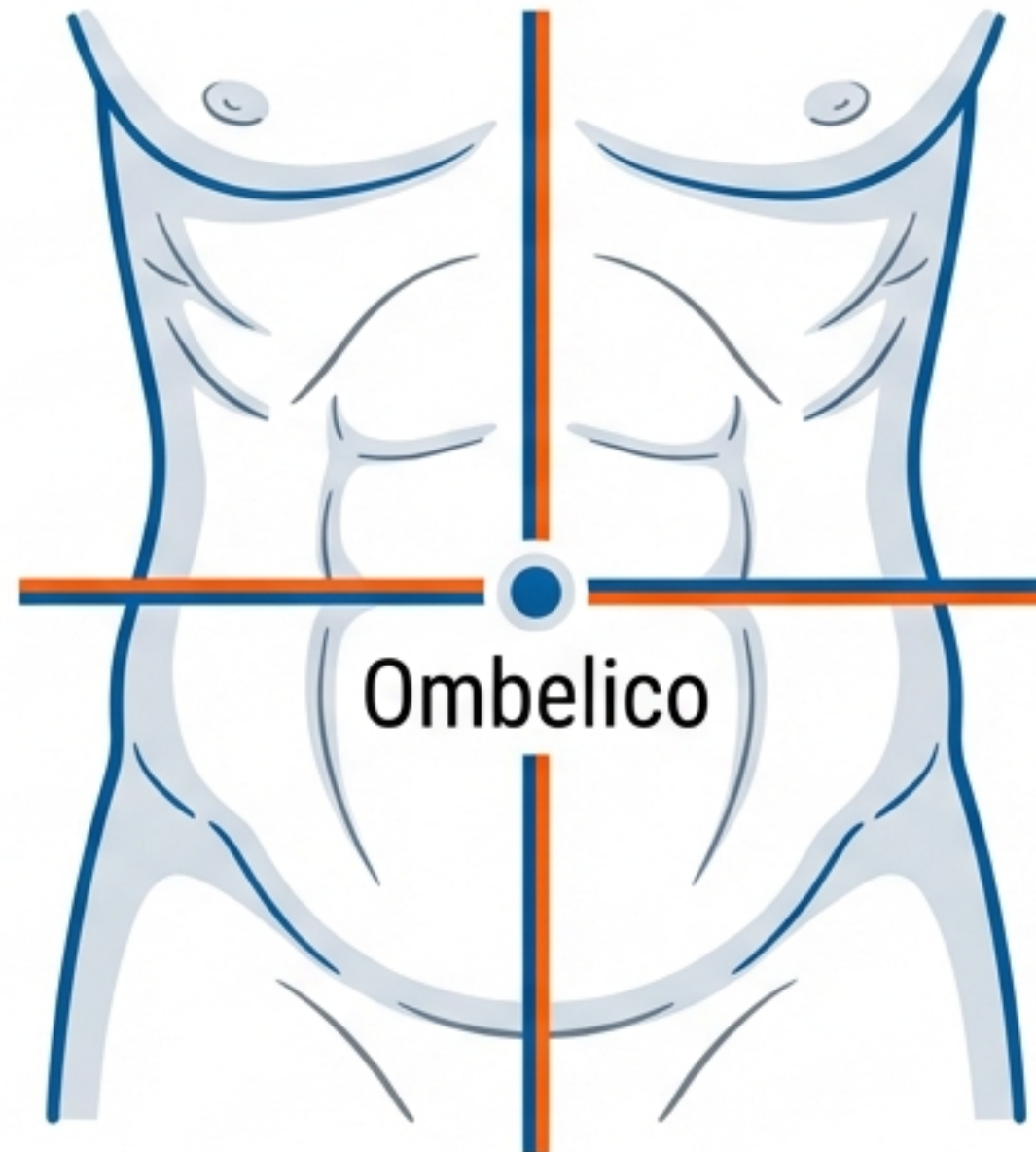


**Monitorare
pervietà vie
aeree (rischio
edema glottide)
→ Codice Rosso**

Dolore Addominale: Il “Quinto Parametro”

Valutazione Roboto Condensed

- Dove? (Quadrante)
- Come? (Urente, (Urente, trafittivo, colica)
- Quando? (Improvviso o graduale)



! **Allarmi (Red Flags): Consed**

! Addome a tavola (Rigido)

! Massa pulsante

! Lipotimia (Svenimento)

Intossicazioni e Sicurezza Scena

Autoprotezione Prima di Tutto

Monossido (CO)



Attenzione ai Cicalini.
Areare i locali immediatamente.

Sostanze Caustiche



Attenzione ai contenitori impropri
(es. bottiglie d'acqua).

! Protocollo Assoluto

1. Non entrare se la scena non è sicura. !
2. Identificare codici Kemler (se presenti). !
3. Portare il contenitore/sostanza in ospedale (in sicurezza). !

Patologie Neurologiche e Degenerative

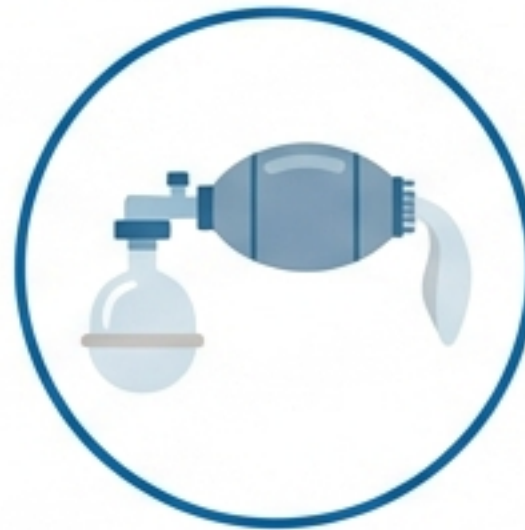
Meningite



Febbre alta + Rigidità nucale.

! Action: Mascherina obbligatoria per operatore e paziente.

SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)



Paziente dipendente da ventilatore.

! Action: Se guasto: Ventilazione manuale + SOREU immediata. Ascoltare il caregiver.

Alzheimer



Deficit di memoria, aggressività.

! Action: Approccio calmo, ripetere le informazioni, non contraddire.

Conclusioni Operative: I Pilastri del Soccorso

Tempo: Raccogliere sempre l'ora di insorgenza.



Monitoraggio: Valutazione continua, non 'una tantum'.

Comunicazione: Segnalare tempestivamente i parametri vitali alterati.



Sicurezza: Mascherine, autoprotezione, limiti operativi (NO diagnosi).

La qualità della tua valutazione determina il destino del paziente.